治疗急性脑梗死的临床研究[J]. 药品评价, 2019, 16(24): 65-66. DOI: 10.3969/j.issn.1672-2809.2019.24.036.

[16] 张应魏, 贝宁, 张润泽, 等. 丁苯酞联合马来酸桂哌齐特对急性脑梗死患者脑血流及神经功能相关指标水平的影响[J]. 疑难病杂志, 2021, 20(3): 217-221. DOI: 10.3969/j.issn.1671-6450.2021.03.001.

[17] 段新辉. 阿司匹林肠溶片联合丁苯酞软胶囊治疗急性脑梗死的效果[J]. 临床合理用药杂志, 2021, 14(14): 43-45. DOI: 10.15887/j.cnki.13-1389/r.2021.14.017.

[18] 徐向东. 阿司匹林联合丁苯酞软胶囊治疗急性脑梗死的效果分析[J]. 河南医学研究, 2017, 26(6): 1096-1097. DOI: 10.3969/j.issn.1004-437X.2017.06.088.

[19] 马妮娜, 白晓黎. 丁苯酞氯化钠注射液联合鼠神经生长因子治疗急性脑梗死的疗效及对炎症因子水平的影响[J]. 西北药学杂志, 2019, 34(5): 670-672. DOI: 10.3969/j.issn.1004-2407.2019.05.023.

[20] 曹亚博, 张菊红, 路怀志. 丁苯酞氯化钠注射液联合阿司匹林阿托伐他汀钙及桂哌齐特治疗急性脑梗死伴认知功能障碍患者的疗效评价[J]. 中国药物与临床, 2022, 22(1): 66-69. DOI: 10.11655/zgywylc2022.01.018.

[21] 李琳, 马亮. 丁苯酞软胶囊联合阿司匹林治疗急性脑梗死的临床效果研究[J]. 中国现代药物应用, 2021, 15(23): 15-18. DOI: 10.14164/j.cnki.cn11-5581/r.2021.23.005.

(收稿日期: 2023-02-28)

丁苯酞氯化钠注射液治疗脑梗死后失语症的临床效果

阳强

作者单位: 412200　湖南省醴陵市中医院

【摘　要】 **目的**　观察丁苯酞氯化钠注射液治疗脑梗死后失语症的临床效果。**方法**　回顾性选择 2020 年 1 月 15 日—2023 年 1 月 15 日醴陵市中医院收治的脑梗死后失语症患者 80 例, 根据治疗方法不同分为试验组和常规组, 每组 40 例。2 组均接受常规治疗, 常规组在常规治疗基础上给予依达拉奉治疗, 试验组在常规治疗基础上给予丁苯酞氯化钠注射液治疗, 2 组均治疗 15 d。比较 2 组临床疗效, 治疗前后生活质量评分、失语评分、美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)评分及不良反应。**结果**　试验组总有效率为 97.50%, 高于常规组的 82.50%($\chi^2=5.000$, $P=0.025$)。治疗 15 d 后, 2 组生理功能、生理职能、躯体疼痛、总体疼痛、活力、社会功能、情感职能、精神健康评分及失语评分高于治疗前, 且试验组高于常规组($P<0.01$); 2 组 NIHSS 评分低于治疗前, 且试验组低于常规组($P<0.01$)。常规组不良反应总发生率为 17.50%, 试验组不良反应总发生率为 2.50%, 2 组比较差异有统计学意义($\chi^2=5.000$, $P=0.025$)。**结论**　丁苯酞氯化钠注射液治疗脑梗死后失语症的临床效果较好, 可改善患者神经功能及失语症状, 提高生活质量。

【关键词】 脑梗死; 失语症; 丁苯酞氯化钠注射液; 治疗效果

【DOI】 10.15887/j.cnki.13-1389/r.2024.19.021

脑梗死为临床常见病、多发病, 近几年, 该病发生率出现逐年增长的态势。中老年为该疾病的好发人群。很多患者治疗后存在后遗症, 失语症是其中的一种。脑梗死后失语症患者往往会表现出自身表达、理解、听力障碍。相关文献证实, 近 33.33% 的患者发病后会出现失语症, 极大程度影响患者的疾病转归[1]。对于脑梗死后失语症患者, 选择有效的治疗方法意义重大。丁苯酞有调节脑能量代谢的效果, 在治疗神经功能损害方面取得一定效果。本研究观察丁苯酞氯化钠注射液治疗脑梗死后失语症的临床效果。现报道如下。

1　资料与方法

1.1　一般资料　回顾性选择 2020 年 1 月 15 日—2023 年 1 月 15 日醴陵市中医院收治的脑梗死后失语症患者 80 例, 根据治疗方法不同分为试验组和常规组, 每组 40 例。试验组男 29 例, 女 11 例; 年龄 42.15~80.25(70.25±3.69)岁。常规组男 30 例, 女 10 例; 年龄 41.25~79.36(69.36±3.11)岁。2 组一般资料比较差异无统计学意义($P>0.05$), 具有可比性。

1.2　病例选择标准　纳入标准: 受试者自愿参加试验调查, 同时签署有关文件; 符合卫计委最新制定的脑梗死后失语症临床诊断标准, 且通过医学影像检查

中国知网　https://www.cnki.net

证实为首次发病;临床资料完整;疾病治疗依从性良好。排除标准:心、肝、肾功能严重不全者;意识障碍者;免疫系统病变者;晚期癌症者;精神疾病者。

1.3　治疗方法　2 组患者均接受常规治疗,维持水电解质平衡,改善机体微循环,稳定斑块,控制血糖血压,抗凝,抗血小板聚集,预防脑水肿,如果患者存在溶栓指征则实施静脉溶栓治疗。常规组在常规治疗基础上应用依达拉奉注射液(湖南一格制药有限公司生产)30 mg 静脉滴注,每天 1 次,治疗 15 d。试验组在常规治疗基础上应用丁苯酞氯化钠注射液(石药集团恩必普药业有限公司生产)25 mg 静脉滴注,每天 2 次,治疗 15 d。

1.4　观察指标与方法　(1)治疗前后生活质量评分:利用简明健康调查量表-36(SF-36)生活质量量表中文版对患者生活质量进行评价,该量表共 8 个维度:生理功能、生理职能、躯体疼痛、总体疼痛、活力、社会功能、情感职能、精神健康,评分越高,表明生活质量越高。(2)治疗前后失语评分:总分为 120 分,>100 分表明患者很少存在可分辨的语言障碍;81 ~ 100 分表明患者语言流利,但是存在理解障碍的情况;61 ~ 80 分表明患者能讨论所有日常问题;41 ~ 60 分表明患者能针对熟悉话题进行交谈;20 ~ 40 分表明患者交流中语言表达不连贯;<20 分表明患者无有意义的语言或听觉理解能力。(3)治疗前后美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)评分:NIHSS 评分越高,表明患者的神经功能缺损越严重。(4)不良反应。

1.5　疗效评定标准　显效:治疗后,临床症状明显缓解,语言功能明显改善;有效:治疗后,临床症状有缓解趋势,语言功能有所改善;无效:未达到以上治疗标准。总有效率 = 显效率 + 有效率。

1.6　统计学方法　应用 SPSS 19.0 统计软件处理和分析数据。计量资料以均数 ± 标准差($\bar{x} \pm s$)表示,组间比较采用 t 检验;计数资料以频数或百分比(%)表示,组间比较采用 χ^2 检验。$P<0.05$ 为差异有统计学意义。

2　结　果

2.1　临床疗效比较　试验组总有效率为 97.50%,高于常规组的 82.50%($\chi^2=5.000$, $P=0.025$),见表 1。

表 1　常规组与试验组临床疗效比较　[例(%)]

组别	例数	显效	有效	无效	总有效率(%)
常规组	40	20(50.00)	13(32.50)	7(17.50)	82.50
试验组	40	22(55.00)	17(42.50)	1(2.50)	97.50[a]

注:与常规组总有效率比较,[a]$P<0.05$

2.2　生活质量评分比较　治疗前,2 组生理功能、生理职能、躯体疼痛、总体疼痛、活力、社会功能、情感职能及精神健康评分比较差异无统计学意义($P>0.05$);治疗 15 d 后,2 组生理功能、生理职能、躯体疼痛、总体疼痛、活力、社会功能、情感职能及精神健康评分高于治疗前,且试验组高于常规组($P<0.01$),见表 2。

2.3　失语评分比较　治疗前,2 组失语评分比较差异无统计学意义($P>0.05$);治疗 15 d 后,2 组失语评分高于治疗前,且试验组高于常规组($P<0.01$),见表 3。

表 3　常规组与试验组治疗前后失语评分比较　($\bar{x} \pm s$,分)

组别	例数	治疗前	治疗后	t 值	P 值
常规组	40	65.26 ± 6.28	84.26 ± 5.29	14.635	<0.001
试验组	40	63.25 ± 5.14	106.36 ± 10.25	23.778	<0.001
t 值		1.566	12.118		
P 值		1.121	<0.001		

2.4　NIHSS 评分比较　治疗前,2 组 NIHSS 评分比较差异无统计学意义($P>0.05$);治疗 15 d 后,2 组 NIHSS 评分低于治疗前,且试验组低于常规组($P<0.01$),见表 4。

2.5　不良反应比较　常规组不良反应总发生率为 17.50%,试验组不良反应总发生率为 2.50%,2 组比较差异有统计学意义($\chi^2=5.000$, $P=0.025$),见表 5。

表 2　常规组与试验组治疗前后生活质量评分比较　($\bar{x} \pm s$,分)

组别	时间	生理功能	生理职能	躯体疼痛	总体疼痛	活力	社会功能	情感职能	精神健康
常规组	治疗前	62.36 ± 1.56	63.25 ± 1.82	64.29 ± 1.57	65.23 ± 1.74	66.39 ± 1.28	67.35 ± 1.36	68.34 ± 1.28	69.35 ± 1.58
(n = 40)	治疗后	75.28 ± 1.58	79.36 ± 1.52	74.18 ± 1.69	75.26 ± 1.69	77.18 ± 1.69	77.18 ± 1.26	78.20 ± 1.28	76.36 ± 1.25
试验组	治疗前	63.25 ± 1.24	64.28 ± 1.36	65.36 ± 1.48	66.36 ± 1.82	67.24 ± 1.54	68.26 ± 1.29	69.34 ± 1.54	70.24 ± 1.52
(n = 40)	治疗后	91.26 ± 1.84	94.18 ± 2.51	95.29 ± 1.17	96.35 ± 1.14	97.14 ± 1.52	94.01 ± 1.28	95.26 ± 1.26	96.77 ± 1.64
t/P 常规组(治疗前后)		36.802/<0.001	42.968/<0.001	27.116/<0.001	26.152/<0.001	32.189/<0.001	33.534/<0.001	34.449/<0.001	22.006/<0.001
t/P 试验组(治疗前后)		79.840/<0.001	66.242/<0.001	100.335/<0.001	88.321/<0.001	87.395/<0.001	89.616/<0.001	82.387/<0.001	75.038/<0.001
t/P 组间值(治疗后)		41.672/<0.001	31.942/<0.001	64.954/<0.001	65.431/<0.001	55.538/<0.001	34.449/<0.001	60.073/<0.001	62.560/<0.001

中国知网　https://www.cnki.net

表 4　常规组与试验组治疗前后 NIHSS 评分比较　($\bar{x} \pm s$, 分)

组别	例数	治疗前	治疗后	t 值	P 值
常规组	40	15.26 ± 2.69	10.25 ± 2.94	7.951	< 0.001
试验组	40	16.23 ± 2.61	7.21 ± 2.81	14.875	< 0.001
t 值		1.637	4.728		
P 值		1.106	< 0.001		

表 5　常规组与试验组不良反应比较　[例(%)]

组别	例数	神经系统	呼吸系统	皮肤	消化系统	总发生率(%)
常规组	40	2(5.00)	1(2.50)	2(5.00)	2(5.00)	17.50
试验组	40	1(2.50)	0	0	0	2.50[a]

注:与常规组总发生率比较,[a]$P < 0.05$

3　讨　论

近年来,我国脑血管疾病的发生率出现逐年增长态势,该病给患者家庭及整个社会带来很大负担。脑血管疾病的出现严重威胁中老年人身体健康及生命安全。脑梗死为现阶段导致我国民众死亡的第二大原因,其与恶性肿瘤、心脏病构成威胁人类身体健康的三大致死类疾病。当前我国已经进入人口老龄化社会,在此背景下,饮食结构及生活方式发生了巨大转变,脑梗死发生率明显上升。相关调查证实,全世界范围内,每年有超 200 万的新发脑梗死病例出现。

急性脑梗死的病理过程相当复杂,研究表明,在急性脑梗死发生及发展过程中,神经元凋亡调控基因表达、炎性反应、钙超载、脑梗死灶周边、半暗带去极化、自由基毒性作用、兴奋氨基酸细胞毒性作用、能量耗竭等过程发挥出了非常重要的作用。临床针对急性脑梗死以对症内科治疗为主,包括改善患者大脑循环、保护神经、抗血小板凝集、抗凝、降纤、溶栓等。超早期溶栓治疗为现阶段公认的高效治疗方法。我国各个地区医疗条件存在差异,值得注意的是,绝大部分患者对该病的认知度不足,导致很多患者错失了从发病到就诊时间 6 h 以内的最佳溶栓治疗时间窗。调查表明,只有少部分患者可以接受超早期溶栓治疗。

脑梗死为成年人重要的致残性疾病,约 60% 的脑梗死患者存在并发症,如脑梗死后失语症。研究表明,脑梗死急性期的梗死灶位置为决定失语症类型的主要因素。值得注意的是,绝大部分失语症患者的临床与影像学特点之间联系支持经典语言中枢定位。随着我国医学技术的不断进展,当前诸多研究证实,失语症的具体类型不完全与经典的解剖学定位相符合。脑梗死患者出现失语症的临床恢复较差,12% ~ 18% 的患者发生脑梗死后半年内仍存在非常显著的语言功能障碍,其中又有 47% 的患者存在轻度语言表达或理解障碍的情况。脑梗死后失语症对患者生活质量造成严重影响,寻找一种高效的治疗方法有相当重要的现实意义[2]。

目前临床还没有完全阐明患者脑梗死后言语功能恢复的详细机制,针对脑梗死后失语症的治疗方法也局限于语言训练方面。近几年,临床尝试开始应用单独或者联合重复经颅刺激及使用细胞活化剂等方法积极促进脑梗死后失语症患者语言功能恢复。但不能忽视的是,以上治疗方法操作比较复杂,加上机体受到其他未知因素影响,导致患者的临床治疗效果存在差异。相关文献表明,当患者大脑组织受损或者发生脑死亡后,会显著降低内皮位置乙酰胆碱递质水平,对患者的记忆力、注意力造成较大影响,重点体现在语言功能方面[3-4]。通过有效方法积极削弱中枢胆碱酯酶效应,降低乙酰胆碱内源性分解能力,在原有基础上增加乙酰胆碱的水平,对于治疗脑梗死后遗症意义重大。

丁苯酞为我国自主研发的用于治疗急性脑梗死新型药品,该制剂包括口服及注射两种剂型[5]。丁苯酞注射液为一类消旋正丁基苯酞,进入人体后,可显著提升大脑缺血位置血流速率,增快缺血部位毛细血管数目与灌注量,改善侧支循环,最终发挥保护患者神经血管的作用。丁苯酞注射液进入人体之后,还可积极阻断缺血大脑损伤多个病理环节,自多靶点体现出抗大脑缺血的作用。丁苯酞具体作用机制为重构大脑微循环,加大缺血区域灌注,有效保护线粒体,维持能量正常代谢[6]。

丁苯酞注射液保护线粒体作用主要为当人体大脑处于缺氧缺血状态时,脑细胞中的 ATP 含量逐渐减少。研究表明,丁苯酞可显著缓解缺血后乳酸上升及磷酸肌酸、ATP 降低速度,减少大脑内动脉短暂阻塞再灌注模型大鼠脑内线粒体 ATP 酶活性度,可维持线粒体正常氧化及产能功效,避免钙超载,缓解因脑缺血而引发的线粒体损伤[7]。丁苯酞可发挥抑制氧化应激的效果,当患者大脑处于缺血状态时,细胞会受到自由基攻击,造成脂质过氧化反应,生成诸多脂质过氧化物[8]。在此过程中,机体会开启内生性保护因子脑红蛋白,而脑红蛋白有提供氧气、抑制氧化应激的效果[9]。研究表明,针对大脑中动脉阻断大鼠

中国知网　https://www.cnki.net

模型给予丁苯酞治疗后不同时间点内处死证实，随着用药时间延长，可在不同程度上调大鼠模型大脑内脑红蛋白表达率，提高 SOD 活性，降低丙二醛水平，改善神经功能缺损[10]。

急性脑梗死后失语症患者应用丁苯酞注射液治疗可改善患者神经功能，其作用可能与药物针对缺血组织中枢胆碱神经元发挥出保护作用有关，经该项机制积极缓解患者神经功能缺损，提升语言功能恢复[11]。本研究结果显示，试验组总有效率高于常规组。治疗 15 d 后，2 组生理功能、生理职能、躯体疼痛、总体疼痛、活力、社会功能、情感职能、精神健康评分及失语评分高于治疗前，且试验组高于常规组；2 组 NIHSS 评分低于治疗前，且试验组低于常规组。2 组不良反应总发生率比较差异无统计学意义。

综上所述，丁苯酞氯化钠注射液治疗脑梗死后失语症的临床效果较好，可改善患者神经功能及失语症状，提高生活质量，值得临床推广和应用。

利益冲突　所有作者声明无利益冲突

参考文献

[1] 温慧萍. 奥瑞姆自理模式联合语言康复训练对脑梗死后运动性失语症患者语言功能的影响研究[J]. 中国现代药物应用，2021，15(23)：232-235. DOI：10. 14164/j. cnki. cn11-5581/r. 2021. 23. 087.

[2] 张贺诚，刘晶，李小圳，等. 静息态功能 MRI 观察脑梗死后失语症患者功能连接变化[J]. 中国医学影像技术，2021，37(9)：1296-1301. DOI：10. 13929/j. issn. 1003-3289. 2021. 09. 004.

[3] 罗聪丽，卢珍友，赖有连，等. 丹膝颗粒联合丁苯酞序贯治疗动脉粥样硬化性脑梗死的疗效观察[J]. 中西医结合心脑血管病杂志，2022，20(15)：2845-2848. DOI：10. 12102/j. issn. 1672-1349. 2022. 15. 032.

[4] 谢涛波，钟纯正，符尧天，等. 阿替普酶静脉溶栓联合丁苯酞治疗对急性重症脑梗死患者神经和凝血功能的影响[J]. 天津医药，2022，50(3)：296-300. DOI：10. 11958/20210957.

[5] 魏从兵，黄启亮，魏进. 丁苯酞联合醒脑静改善急性后循环脑梗死患者日间过度嗜睡状态[J]. 神经损伤与功能重建，2022，17(7)：432-433. DOI：10. 16780/j. cnki. sjssgncj. 20200893.

[6] 白雪峰，任凤霞. 自拟益气活血通络方联合丁苯酞注射液治疗对急性脑梗死患者 Hcy、hs-CRP 及 D-Dimer 水平的影响[J]. 贵州医药，2022，46(6)：945-946. DOI：10. 3969/j. issn. 1000-744X. 2022. 06. 059.

[7] 穆永芳，郭永力，蒋召芹，等. 丁苯酞与阿替普酶对急性脑梗死溶栓患者神经功能、凝血功能及血清炎症因子水平影响[J]. 临床军医杂志，2021，49(7)：806-808. DOI：10. 16680/j. 1671-3826. 2021. 07. 35.

[8] 姜楠，赵连东，翟正平，等. 丁苯酞联合脑苷肌肽对急性脑梗死神经功能缺损、日常生活活动能力的改善作用[J]. 湖南师范大学学报(医学版)，2021，18(2)：267-270. DOI：10. 3969/j. issn. 1673-016X. 2021. 02. 077.

[9] 张应魏，贝宁，张润泽，等. 丁苯酞联合马来酸桂哌齐特对急性脑梗死患者脑血流及神经功能相关指标水平的影响[J]. 疑难病杂志，2021，20(3)：217-221. DOI：10. 3969/j. issn. 1671-6450. 2021. 03. 001.

[10] Niu H, Zhang Z, Wang H, et al. The impact of butylphthalide on the hypothalamus-pituitary-adrenal axis of patients suffering from cerebral infarction in the basal ganglia[J]. Electronic Physician, 2016, 8(1)：1759-1763. DOI：10. 19082/1759.

[11] 娄永忠，王涛. 丁苯酞治疗急性脑梗死作用的临床研究进展[J]. 黑龙江医学，2021，45(15)：1678-1681. DOI：10. 3969/j. issn. 1004-5775. 2021. 15. 041.

(收稿日期：2023－05－05)

(上接第 72 页)

[10] 李强，朱曦，么改琦. 右美托咪定联合咪达唑仑在 ICU 短时间机械通气患者中的镇静效果和安全性评价[J]. 中国微创外科杂志，2019，19(6)：534-537. DOI：10. 3969/j. issn. 1009-6604. 2019. 06. 015.

[11] 姚玲，刘博，何天慧，等. 右美托咪定与咪达唑仑对脓毒性休克患者血浆儿茶酚胺水平及血流动力学影响的对比研究[J]. 中华危重病急救医学，2021，33(10)：1193-1197. DOI：10. 3760/cma. j. cn121430-20210119-00105.

[12] 蒋忠洋，孙欢，马世伟，等. 右美托咪啶联合瑞芬太尼在 ICU 患者镇痛镇静中的应用观察[J]. 陕西医学杂志，2020，49(3)：341-344，348. DOI：10. 3969/j. issn. 1000-7377. 2020. 03. 020.

[13] 王学良. 芬太尼、舒芬太尼、瑞芬太尼对全身麻醉诱导循环的影响对比[J]. 吉林医学，2020，41(3)：606-607.

[14] 赵千文，吴海华，谢玉萍. 舒芬太尼联合咪达唑仑对机械通气脓毒症患者镇静效果及炎症因子的影响[J]. 临床肺科杂志，2019，24(8)：1446-1449，1469. DOI：10. 3969/j. issn. 1009-6663. 2019. 08. 022.

[15] 章冰玉，任大力，郭恩伟，等. 咪达唑仑联合瑞芬太尼对多发伤患者炎症反应和预后的影响[J]. 创伤外科杂志，2020，22(8)：627-629. DOI：10. 3969j. issn. 1009-4237. 2020. 08. 017.

[16] 刘星，邱德亮，王左峰，等. 咪达唑仑联合瑞芬太尼在脊椎骨折手术中的麻醉效果及对血流动力学的影响[J]. 医学临床研究，2019，36(5)：888-890. DOI：10. 3969/j. issn. 1671-7171. 2019. 05. 018.

(收稿日期：2023－05－10)

中国知网　https://www.cnki.net